Biologia

Prof. Fábio



PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: Cursinho da Poli

Biologia A

verminoses

Professor Fábio

Esquistossomose

Agentes etiológicos:

Schistosoma mansoni: África, Antilhas e América do Sul;

Schistosoma haematobium: Egito, Oriente Médio, parte da África;

Schistosoma japonicum: Japão, China, Filipinas e sudeste asiático;

Schistosoma mekongi: Camboja;

Schistosoma intercalatum: África central

Platelmintos (“vermes achatados”)

da Classe Trematoda

Esquistossomose









Esquistossomose

Hospedeiro intermediário (HI):

Caramujos do gênero Biomphalaria:

- B. glabrata (transmissora)
- B. tenagophila (transmissora)
- B. straminea (transmissora)
- B. amazonica
- B. peregrina
- B. occidentalis
- B. intermedia
- B. schrammi
- B. oligoza
- B. kuhniana





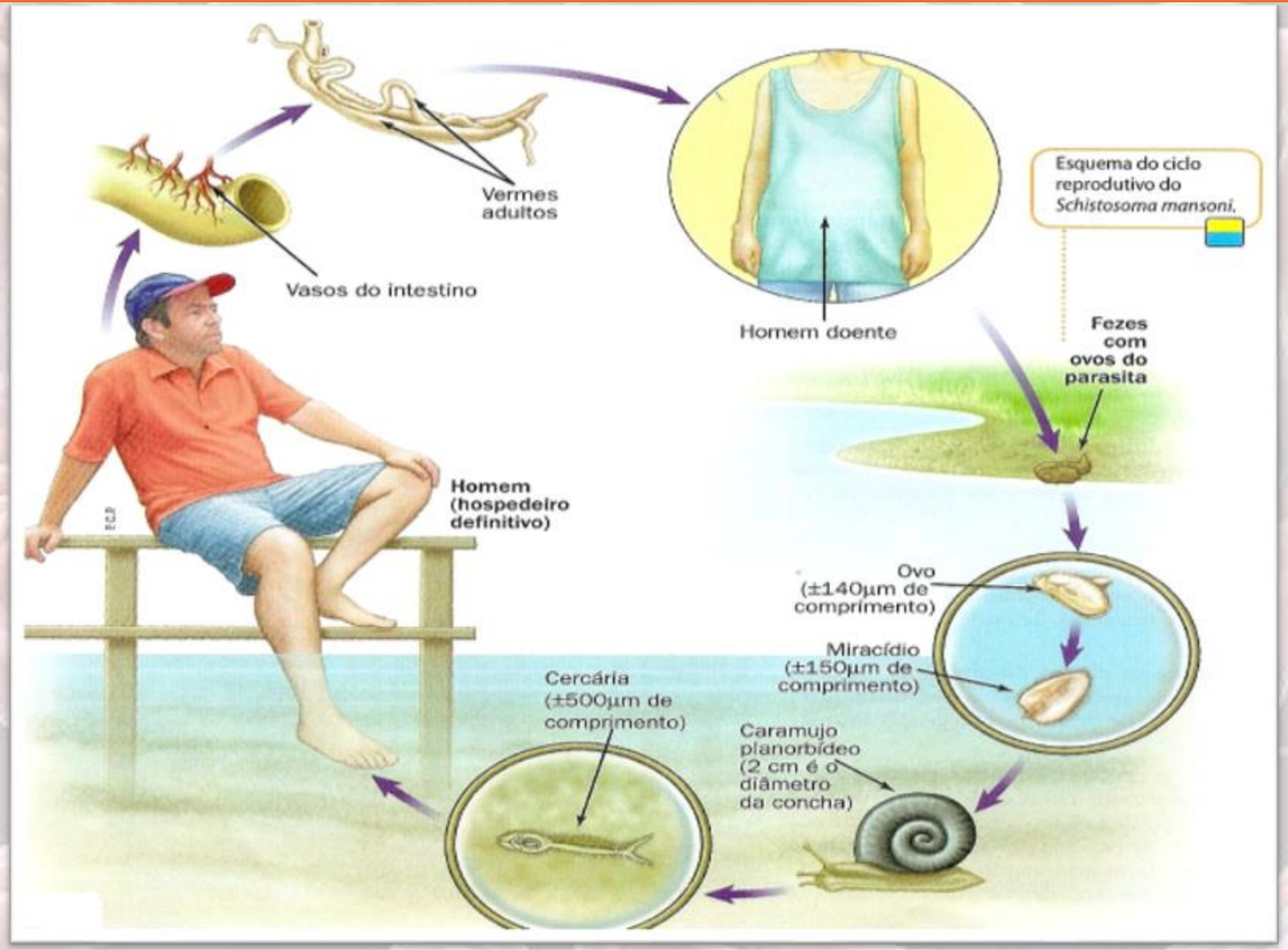
Esquistossomose transmissão







Esquistossomose ciclo da doença



Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-WwV3cgA48C4/UmZoxwHj8BI/AAAAAAAAAuY/nVRhP3lwPE/s1600/ciclo+esquistossomose.jpeg

Esquistossomose sintomas

Cercária: dermatite cercariana

Esquistossômulos: febre, aumento do baço, sintomas pulmonares

Vermes adultos: (vivos) anemia, (mortos) lesões no fígado

Ovos: (intestino) hemorragia, edemas e úlceras; (fígado) granulomas

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-WwV3cgA48C4/UmZoxwHj8BI/AAAAAAAAAuY/nVRhP3lwPE/s1600/ciclo+esquistossomose.jpeg

Esquistossomose sintomas

Fase aguda: assintomática, febre, problemas pulmonares, dores musculares, desconforto abdominal e hepatite aguda, necrose da parede intestinal, granulomas, hepatoesplenomegalia e morte.

Fase crônica: (intestino) dor abdominal, diarreia mucossanguinolenta, fibrose, diminuição do peristaltismo; (fígado) granulomas, aumento e dor no órgão, cirrose hepática.

Varizes esofagianas podem aparecem como maneira de compensar a obstrução sanguínea da veia porta hepática.

Pode ocorrer hemorragia, muitas vezes fatais.

Esquistossomose sintomas







Esquistossomose profilaxia

Combate aos caramujos

Tratamento dos doentes

Vacinas (final de 2025)

Saneamento básico

Não ter contato com águas suspeitas (não entrar)

Teníase e Cisticercose

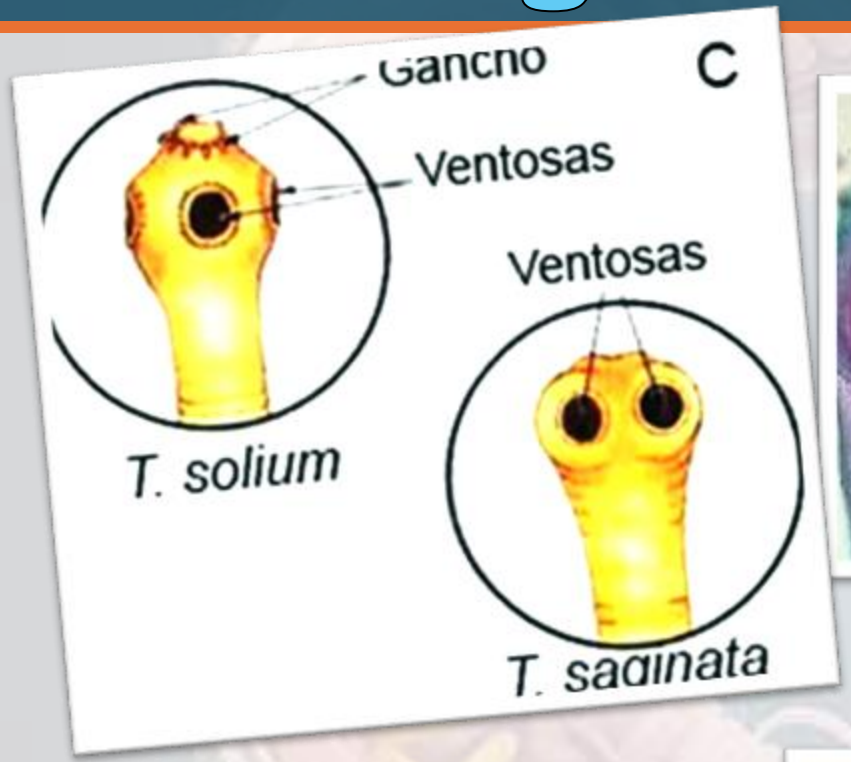
Agentes etiológicos

Taenia solium

Taenia saginata

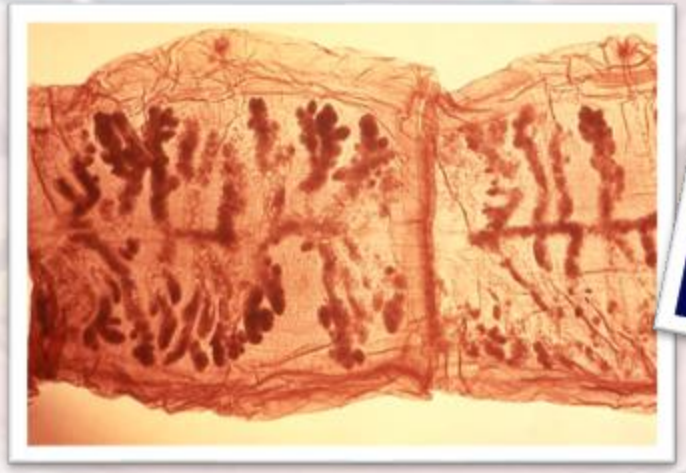
Platelmintos (“vermes achatados”)
da Classe Cestoda

Morfologia das tênias

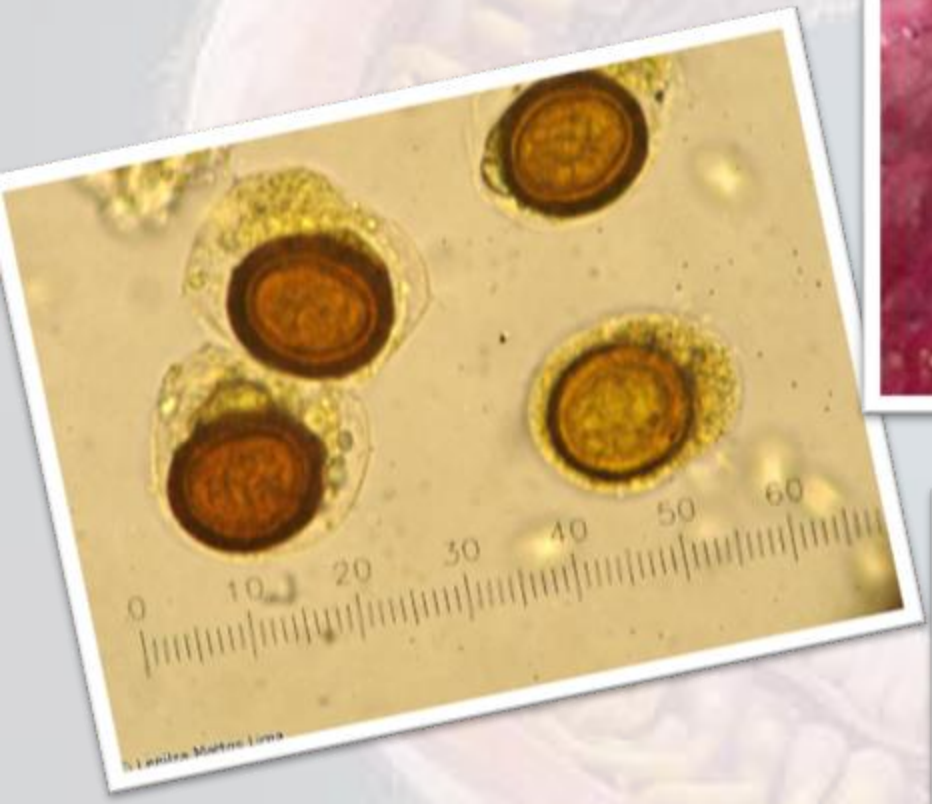








Morfologia das tênias









Hospedeiro intermediário

T. solium (fase adulta ou reprodituva):

Intestino delgado de humanos

T. solium (cisticercos):

Tecido subcutâneo, muscular, cardíaco, cerebral, glândulas mamárias (rara) e olho de suínos e acidentalmente de cães e humanos.

T. saginata (cisticercos):

Tecidos de bovinos.

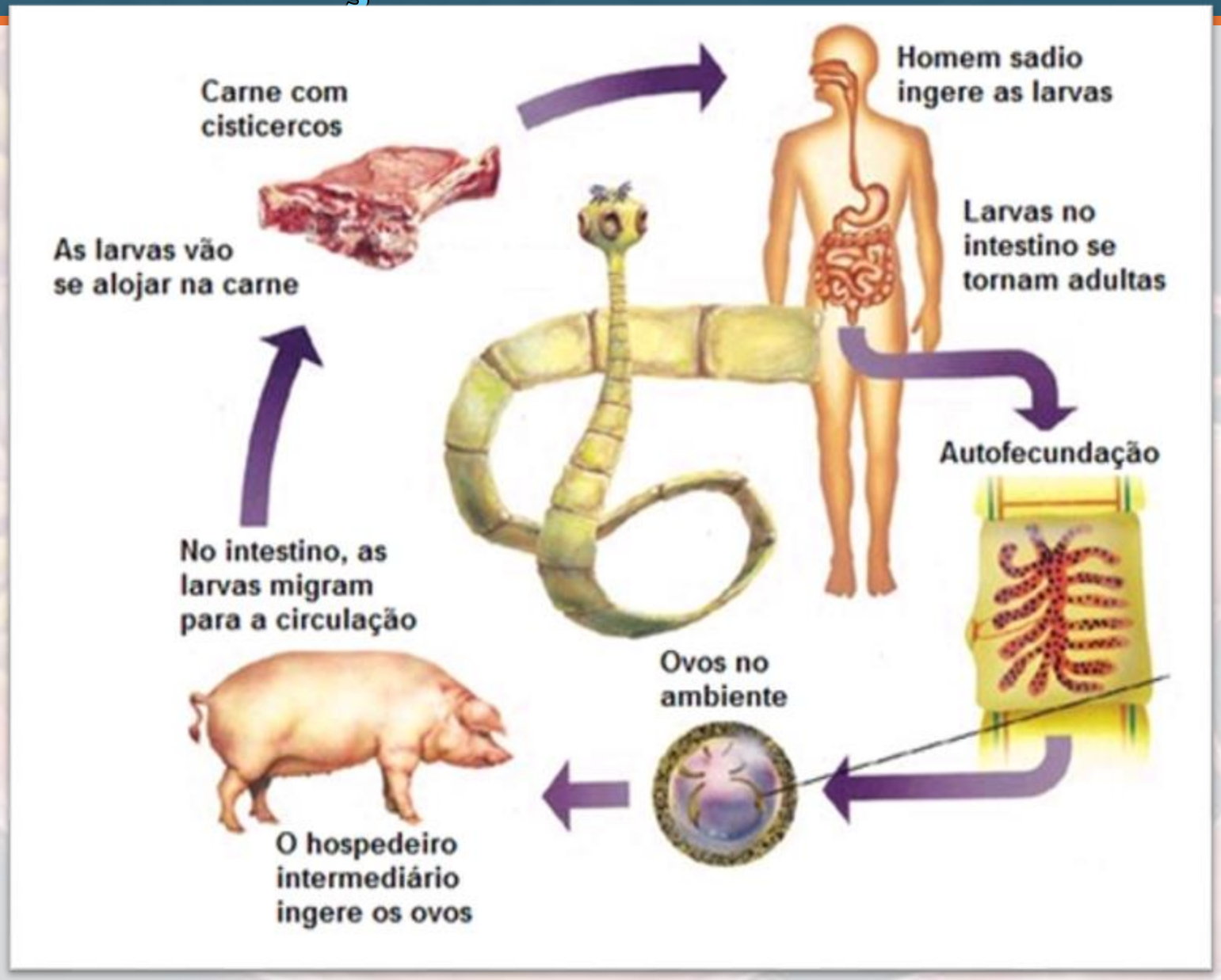
transmissão

Teníase: ingestão de carne suína ou bovina, crua ou mal cozida, infectada com cisticercos das tênias.

Cisticercose: ingestão acidental de ovos viáveis de *T. solium* que foram eliminados nas fezes dos portadores de teníase.

Auto infecção externa: mãos contaminadas;
Auto infecção interna: vômitos;
Heteroinfecção: alimentos ou água infectada.

Ciclo da doença



Patogenia e sintomas

Teníase:

hemorragias, inflamação do epitélio intestinal, dores abdominais, alargamento do abdômen, deficiência nutricional, obstrução intestinal.

Patogenia e sintomas

Cisticercose

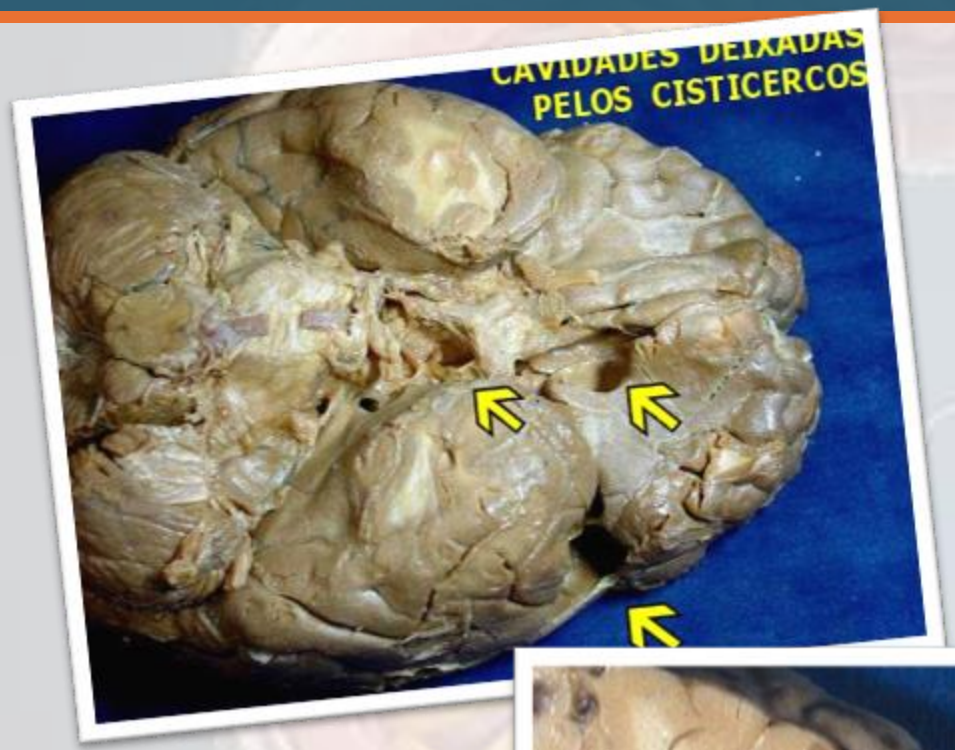
Músculos esqueléticos: fadiga, câimbras, dor

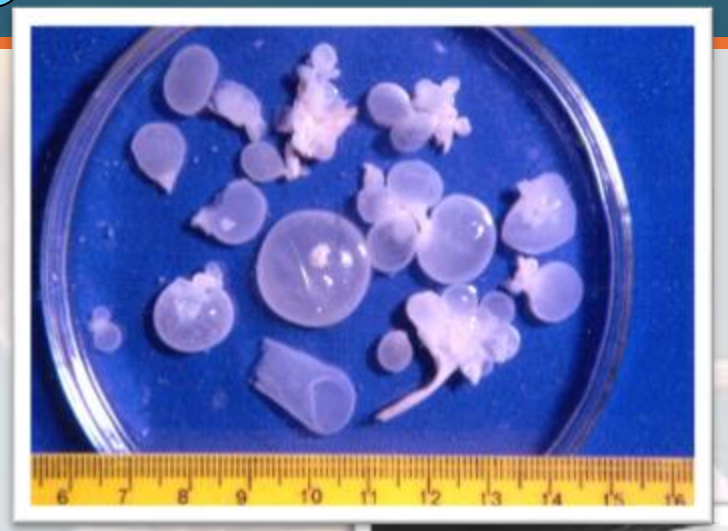
Músculo cardíaco: palpitações

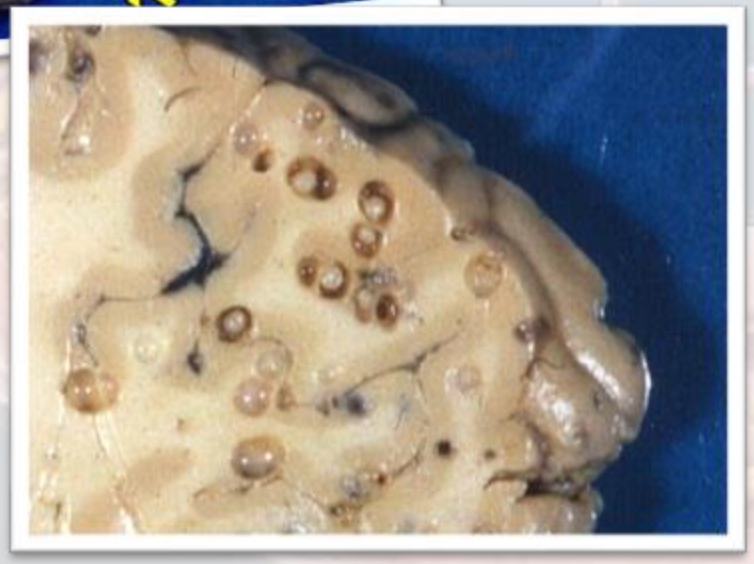
Olhos: deslocamento da retina, perfuração da retina, reações inflamatórias, perda parcial ou total da visão e/ou perda do globo ocular

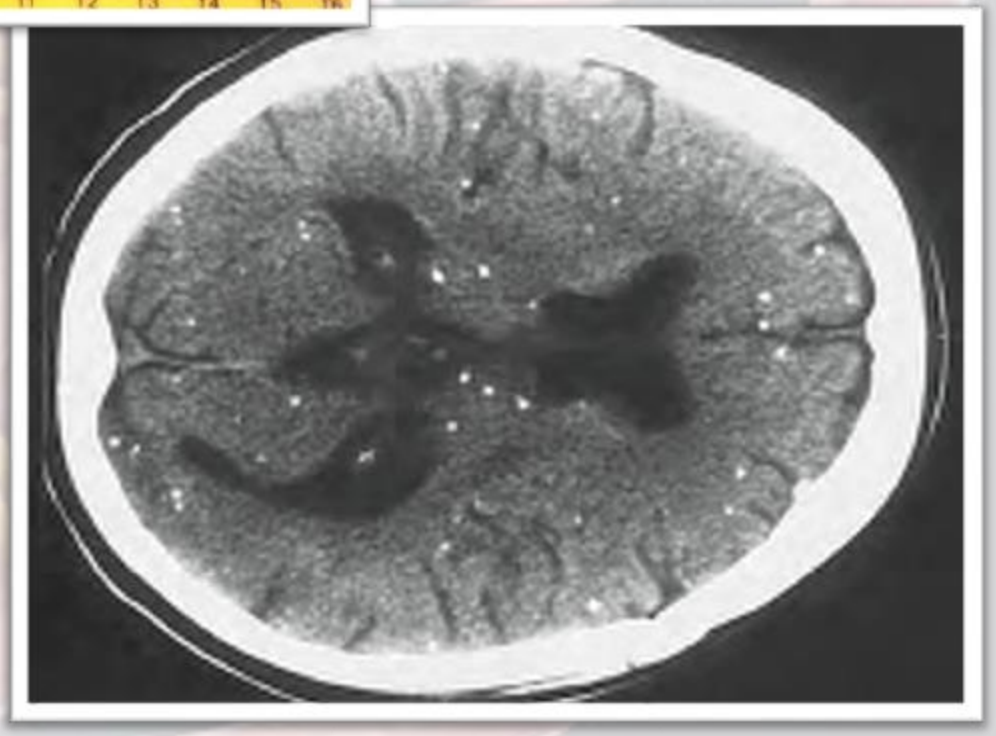
Sistema nervoso central (neurocisticercose): obstrução do líquido cefalorraquidiano, aumento da pressão intracraniana, hidrocefalia, calcificações (ataques epilépticos).

Neurocisticercose









Profilaxia

Tratamento dos doentes

Saneamento básico

Não ingerir carne bovina ou suína, crua ou mal passada (teníase)

Não ingerir alimentos sem o devido cuidado com a higiene (cisticercose)

Não ingerir água sem tratamento (cisticercose)

Ascaridíase

Agentes etiológicos:

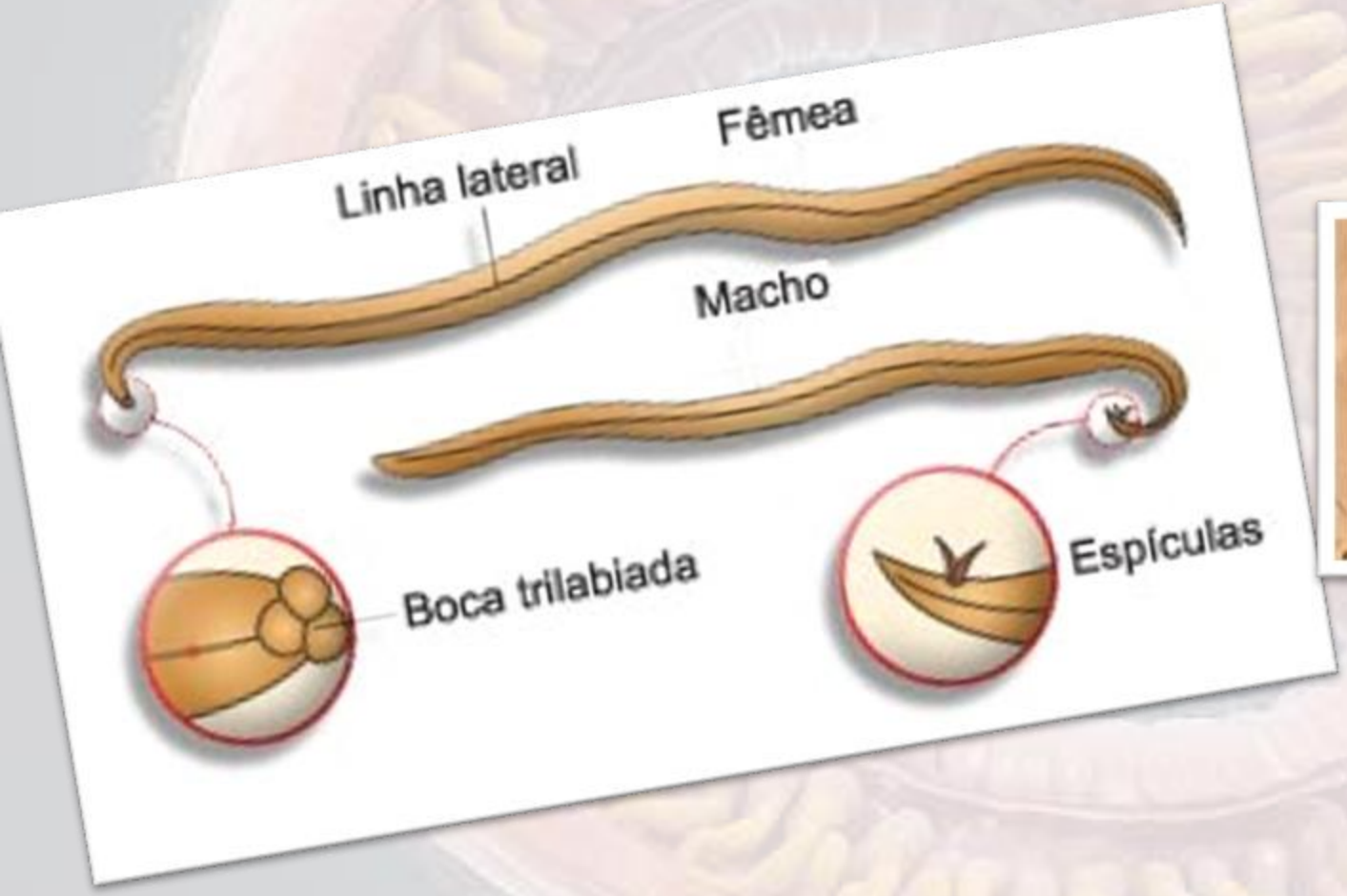
Ascaris lumbricoides: ser humano

Ascaris suum: suínos

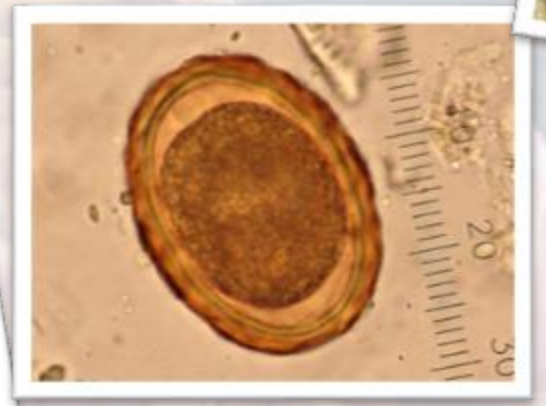
Nematelmintos ("vermes cilíndricos")

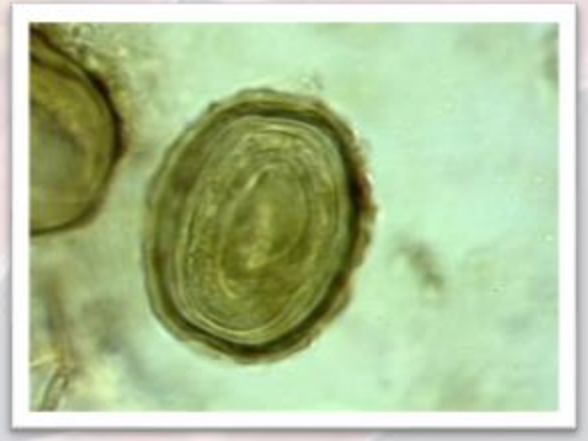
Classe Secernentea

Ascaridíase - morfologia









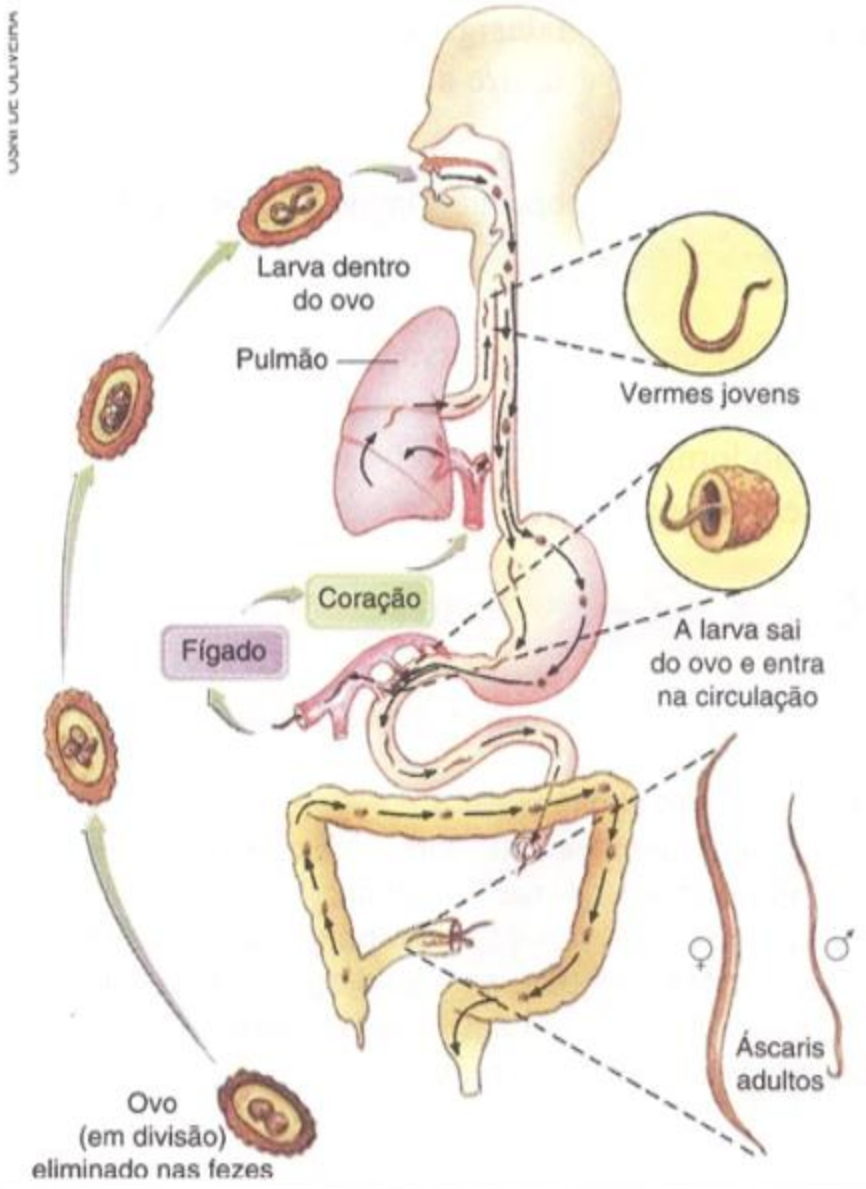
Ascaridíase - transmissão

Ingestão de água ou alimentos contaminados pelos ovos de áscaris contendo a L3





Ascaridíase – ciclo da doença



Ciclo Ascaridíase



Ascaridíase – patogenia e sintomas

Larvas

baixas quantidades = assintomática

infecção maciça = lesões hepáticas e pulmonares.
No fígado causa necrose e fibrose, nos pulmões causa reações alérgicas, febre, bronquite e
PNEUMONIA

Ascaridíase – patogenia e sintomas

Vermes adultos:

baixas quantidades = assintomática

infecção maciça = cólicas, dores abdominais, desnutrição, irritação e obstrução do intestino.

Tanto com as larvas quanto com os vermes adultos, o paciente pode apresentar quadros de hemorragia.

Ascaridíase – patogenia e sintomas









Ascaridíase – profilaxia

Tratamento em massa dos doentes

Educação da população

Saneamento básico

Hábitos de higiene pessoal

Ancilostomose

Agentes etiológicos:

Ancylostoma duodenale (ser humano)
Necator americanus (ser humano)
Ancylostoma ceylanicum (canídeos e felídeos domésticos)

Nematelmintos ("vermes cilíndricos")
da Classe Secernentea

Ancilostomose







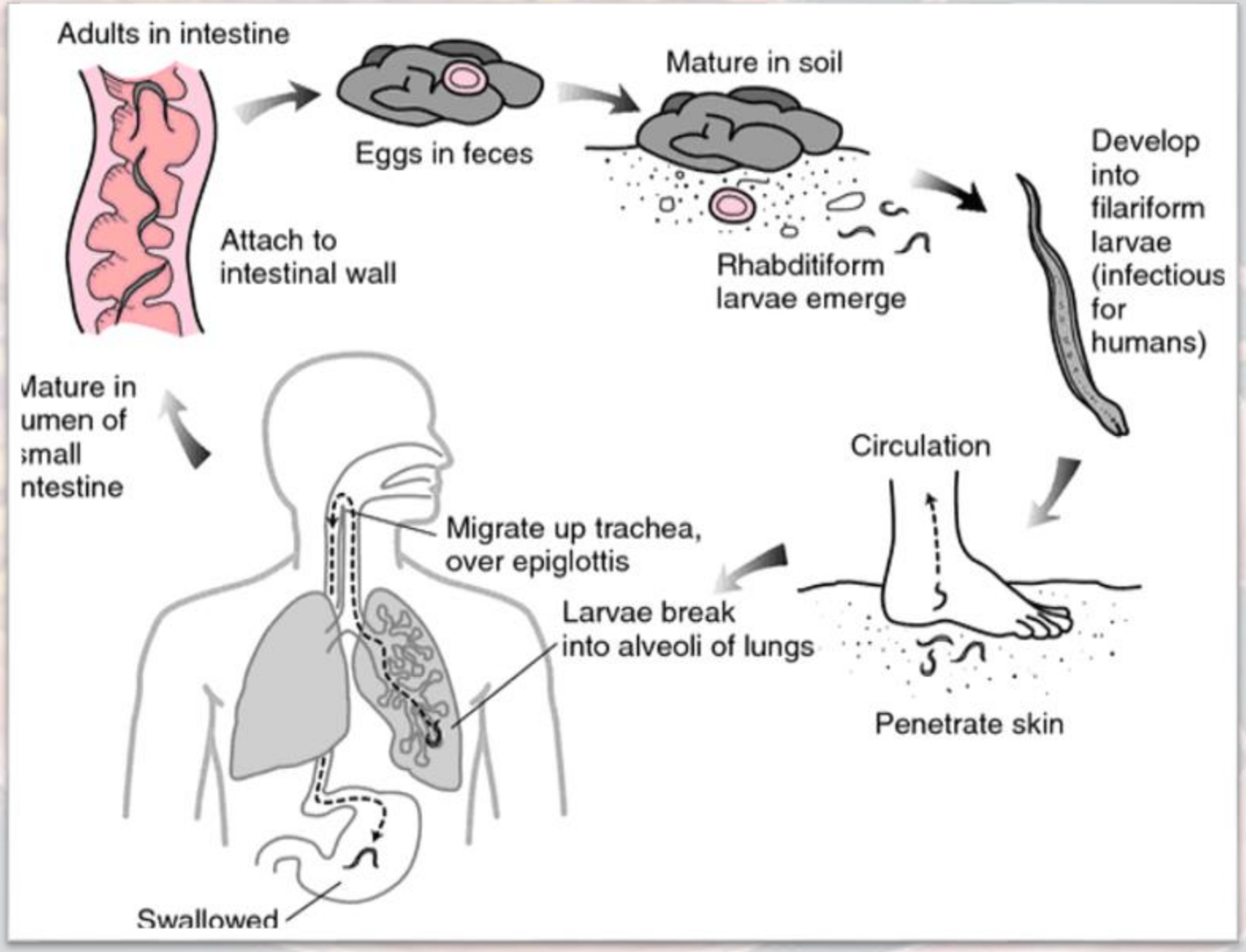


Ancilostomose - transmissão

Via oral
(ingestão de ovos embrionados)

Via transcutânea
(penetração das larvas pela pele)

Ancilostomose – ciclo da doença



Ancilostomose – patogenia e sintomas

Dermatites

Diminuição do apetite

Dores abdominais

Indigestão

Vômitos

Desnutrição

Anemia ferropriva

Problemas pulmonares

Geofagia

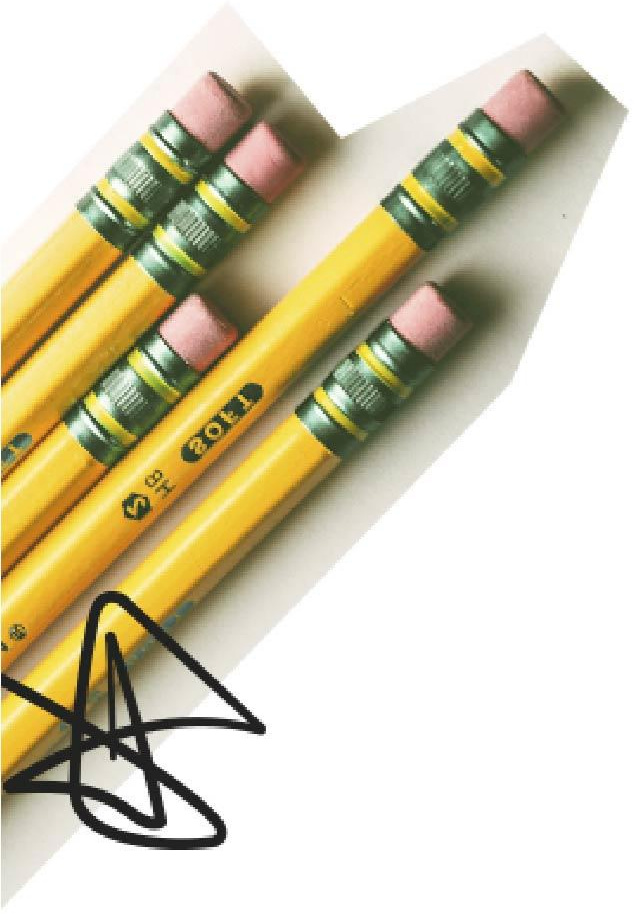
Ancilostomose – profilaxia

Tratamento dos doentes

Saneamento básico

Não andar descalço

Bons hábitos de higiene



Até a próxima, pessoal!

Fábio José Machado



CURSINHO da POLI